

CAPÍTULO 9.5

Anemia Hemolítica

PERFIL EUNACOM 1.071.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia Hemolítica

Clínica

- Síndrome anémico + **ictericia** + **orinas oscuras** (hemoglobinuria o coluria)
- Dolor abdominal (la fisiopatología no es clara, pero es descrito)
- Triada: **palidez** + **ictericia** + **esplenomegalia** en formas crónicas

Diagnóstico

- Hemograma: Anemia: Generalidades** | anemia ± macrocítica (reticulocitos son grandes) + **esquistocitos/fragmentocitos** en frotis
- Reticulocitos** ↑ (IR > 2) → anemia **regenerativa** en ausencia de hemorragia aguda = hemólisis hasta demostrar lo contrario
- LDH** ↑ (marcador de destrucción celular — inespecífico)
- Bilirrubina indirecta** ↑
- Haptoglobina** ↓ (proteína que captura Hb libre; se agota en hemólisis)

EUNACOM CRITERIOS

Prueba de Coombs directa (+) = anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (la más frecuente). Coombs (–) → otras causas (microangiopática, genética, infecciosa, etc.)

Causas

TABLA 9.5.1: TIPO VS EJEMPLOS	
TIPO	EJEMPLOS
Autoinmune anticuerpos calientes	Idiopática, LES, linfomaFármaco (metildopa)
Autoinmune anticuerpos fríos (crioaglutininas)	Post-infección (Mycoplasma), rara
Microangiopática	SHU, PTT, síndrome HELLP, CID
Genética	Esferocitosis hereditaria, talasemia, drepanocitosis
Infecciosa	Malaria, Clostridium

Tratamiento

TABLA 9.5.2: CAUSA VS TRATAMIENTO	
CAUSA	TRATAMIENTO
Autoinmune (anticuerpos calientes)	Corticoides EV → Rituximab → IgG EV (si refractario)
Microangiopática (PTT/SHU)	Plasmaféresis / tratar causa

| Crisis aplásica o anemia muy severa | **Transfusión** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 30 años con antecedente de Lupus Eritematoso Sistémico consulta por astenia, ictericia escleral e ictericia cutánea leve sin coluria ni acolia. Hemograma: Hb 7.8 g/dL, VCM 98 fL, Reticulocitos 6.5% (IPR 3.8%). Laboratorio: LDH 920 UI/L, Bilirrubina Total 4.2 mg/dL (Indirecta 3.6 mg/dL), Haptoglobina < 5 mg/dL (indetectable). Test de Coombs Directo positivo (IgG + C3d)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Anemia Hemolítica Autoinmune (AHA) por Anticuerpos Calientes (IgG): tríada de Anemia + Ictericia a expensas de Bilirrubina Indirecta + Reticulocitosis marcada (regenerativa), con LDH elevada y Haptoglobina consumida. Coombs directo positivo confirma el mecanismo inmunológico. Tratamiento de primera línea: Corticoides sistémicos a dosis altas (Prednisona 1-1.5 mg/kg/día). Ácido fólico de mantención.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El diagnóstico se basa en reticulocitos elevados (anemia regenerativa) sin hemorragia aguda reciente
- Clínica: ictericia, orinas oscuras (hemoglobinuria o coluria) y dolor abdominal
- Esquistocitos/fragmentocitos en el frotis son muy sugerentes de hemólisis
- Exámenes complementarios: LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada, haptoglobina disminuida
- La prueba de Coombs directa es positiva en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, no en toda hemólisis
- Causas principales: autoinmune, microangiopática (SHU, PTT, HELLP), genéticas, infecciosas
- Tratamiento de la autoinmune: corticoides EV, rituximab, IgG endovenosa
- La anemia hemolítica por aglutininas frías tiene Coombs negativo y se asocia a fenómenos de Raynaud

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA HEMOLÍTICA)

PREGUNTA 1

Paciente con anemia, reticulocitos elevados, LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada y haptoglobina baja. No tiene antecedente de hemorragia reciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Anemia ferropénica
- B) Anemia por enfermedades crónicas
- C) Anemia hemolítica
- D) Anemia por déficit de vitamina B12
- E) Mielodisplasia

PREGUNTA 2

¿Cuál es la utilidad específica de la prueba de Coombs directa en el contexto de anemia hemolítica?

- A) Confirma el diagnóstico de cualquier anemia hemolítica
- B) Diagnostica específicamente la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes
- C) Diagnostica la anemia hemolítica por aglutininas frías
- D) Diferencia las anemias hemolíticas microangiopáticas entre sí
- E) Mide la gravedad de la hemólisis

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes tratamientos ha desplazado a la inmunoglobulina G endovenosa como tratamiento principal de la anemia hemolítica autoinmune?

- A) Esplenectomía
- B) Plasmaféresis
- C) Rituximab
- D) Ciclofosfamida
- E) Metotrexato

RESUMEN: ANEMIA HEMOLÍTICA

Esta clase aborda la anemia hemolítica, una anemia regenerativa cuyo diagnóstico se basa en el aumento de reticulocitos en ausencia de hemorragia aguda reciente. La clínica incluye síndrome anémico, ictericia, orinas oscuras (hemoglobinuria o coluria) y dolor abdominal. El hemograma muestra reticulocitos elevados, esquistocitos/fragmentocitos en el frotis, y VCM que puede estar normal o elevado. Los exámenes complementarios incluyen LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada y haptoglobina disminuida. Las causas son múltiples: anemia hemolítica autoinmune (por anticuerpos calientes o fríos/aglutininas frías), microangiopatías (SHU, PTT, HELLP), genéticas (microesferocitosis familiar, hemoglobinopatías) e infecciosas (malaria). La prueba de Coombs directa es positiva específicamente en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. El tratamiento incluye transfusión en casos graves, corticoides endovenosos, rituximab e inmunoglobulina G endovenosa para la forma autoinmune.